

Nombre del Prestador :	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
Seguro	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Nombre del Paciente	ARTEAGA ZAMBRANO BLANCA EDITH
Cedula de identidad	1301810196
Historia Clínica	10196
Fecha de Ingreso	2025-10-21
Fecha de Egreso	2025-10-21
Procedimiento	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+RETIRO DE SETENT
Diagnostico	(K802) CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS
PLANILLA DE CARGOS DEL PROVEEDOR(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA)	

HONORARIOS MEDICOS								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-21	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	1	\$160,30	\$160,30	\$0,00	\$0,0000	\$160,30
2025-10-21	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	1	\$60,60	\$60,60	\$0,00	\$0,0000	\$60,60
2025-10-21	43256	TIEMPO DE ANESTESIA	4	\$12,12	\$48,48	\$0,00	\$0,0000	\$48,48
2025-10-21	43247	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, PARA REMOCION DE CUERPO EXTRAÑO.	1	\$41,68	\$41,68	\$0,00	\$0,0000	\$41,68
Total			HONORARIOS MEDICOS					\$311,06

MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-21		SEVOFLURANO INHALACION. SOLUCION PARA INHALACION 1 MG/ML. PRESENT. 250ML	49	\$0,86	\$42,14	\$0,00	\$0,0000	\$42,14
2025-10-21		LACTATO RINGER LIQUIDO PARENTERAL PARA INFUSION ND 1000 ML. PRESENT. 1000 ML (1000ML)	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
2025-10-21		PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL EMULSION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA/FRASCO. PRESENT. 200MG/20 ML	30	\$1,04	\$31,20	\$0,00	\$0,0000	\$31,20
2025-10-21		ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML PRESENT 50MG/5ML	1	\$10,29	\$10,29	\$0,00	\$0,0000	\$10,29
2025-10-21		LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 2% PRESENT. 10 ML	1	\$1,32	\$1,32	\$0,00	\$0,0000	\$1,32
2025-10-21		BUTIL ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) - LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 20MG / ML PRESENT.20MG	1	\$1,27	\$1,27	\$0,00	\$0,0000	\$1,27
2025-10-21		ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 8MG PRESENT.8MG/4ML	1	\$3,02	\$3,02	\$0,00	\$0,0000	\$3,02
2025-10-21		FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,05MG/10ML	1	\$0,25	\$0,25	\$0,00	\$0,0000	\$0,25
2025-10-21		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML PRESNT. 4MG/ML	2	\$0,34	\$0,68	\$0,00	\$0,0000	\$0,68
2025-10-21		CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL POLVO PARA INYECCION 1G PRESENT. 1GR	1	\$7,63	\$7,63	\$0,00	\$0,0000	\$7,63
2025-10-21		ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 1 MG - ML PRESNT. 1ML	1	\$0,45	\$0,45	\$0,00	\$0,0000	\$0,45
2025-10-21		NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG / ML PRESENT 0,5 MG /1ML	4	\$0,64	\$2,56	\$0,00	\$0,0000	\$2,56
2025-10-21		KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 30 MG / ML PRESENT. 30 MG	2	\$2,15	\$4,30	\$0,00	\$0,0000	\$4,30
2025-10-21		OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	1	\$5,46	\$5,46	\$0,00	\$0,0000	\$5,46
Total			MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN					\$112,50

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-21		OXIGENO LITROS MINUTO	300	\$0,01	\$3,00	\$0,00	\$0,0000	\$3,00
2025-10-21		Empujador 7 fr, long catéter 2200 mm, canal de trabajo 2.8 Estéril. Descartable	1	\$180,00	\$198,00	\$18,00	\$29,7000	\$227,70
2025-10-21		Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable	1	\$440,00	\$484,00	\$44,00	\$72,6000	\$556,60
2025-10-21		STENT PLASTICO BILIAR DOBLE PIGTAIL 7FR X 5CM ESTERIL. DESCARTABLE	1	\$154,55	\$170,01	\$15,46	\$25,5015	\$195,51
2025-10-21		CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE	1	\$20,00	\$22,00	\$2,00	\$3,3000	\$25,30
2025-10-21		Esfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable	1	\$665,00	\$731,50	\$66,50	\$109,7250	\$841,23
2025-10-21		FORCEPS PINZA RATON (2.5MM/180CM) DESCARTABLE	1	\$510,00	\$561,00	\$51,00	\$84,1500	\$645,15
2025-10-21		KIT-CIRCUITO DE ANESTESIA DESCARTABLE	1	\$13,00	\$14,30	\$1,30	\$2,1450	\$16,45
2025-10-21		ELECTRODOS 3M DESCARTABLE	3	\$0,28	\$0,93	\$0,08	\$0,1395	\$1,07
2025-10-21		BOLSA DE SUCCION DESCARTABLE	1	\$4,50	\$4,95	\$0,45	\$0,7425	\$5,69
2025-10-21		EQUIPO VENOCCLISIS DESCARTABLE	1	\$0,29	\$0,32	\$0,03	\$0,0480	\$0,37
2025-10-21		CATETER N°20 DESCARTABLE	1	\$0,75	\$0,83	\$0,08	\$0,1245	\$0,95
2025-10-21		MANGUERA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$2,75	\$3,03	\$0,28	\$0,4545	\$3,48
2025-10-21		JERINGAS DE 10 ML DESCARTABLE	2	\$0,11	\$0,24	\$0,02	\$0,0360	\$0,28
2025-10-21		JERINGAS DE 20 ML DESCARTABLE	2	\$0,18	\$0,40	\$0,04	\$0,0600	\$0,46
2025-10-21		Bite Block Adulto DESCARTABLE	1	\$8,00	\$8,80	\$0,80	\$1,3200	\$10,12
2025-10-21		SONDA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$0,90	\$0,99	\$0,09	\$0,1485	\$1,14
2025-10-21		BATA PACIENTE DESCARTABLE	1	\$1,20	\$1,32	\$0,12	\$0,1980	\$1,52
2025-10-21		BATA QUIRURGICA M DESCARTABLE	3	\$1,30	\$4,29	\$0,39	\$0,6435	\$4,93
2025-10-21		GORRO QUIRURGICOS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-21		MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-21		ZAPATONES DESCARTABLE	8	\$0,20	\$1,76	\$0,16	\$0,2640	\$2,02
2025-10-21		GUANTES MANEJO M-S DESCARTABLE	6	\$0,07	\$0,48	\$0,04	\$0,0720	\$0,55
2025-10-21		TEGADERM APOSITO DE FIJACION DESCARTABLE	1	\$0,70	\$0,77	\$0,07	\$0,1155	\$0,89
2025-10-21		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENCION DESCARTABLE	1	\$0,30	\$0,33	\$0,03	\$0,0495	\$0,38
2025-10-21		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0MM DESCARTABLE	1	\$1,85	\$2,04	\$0,19	\$0,3060	\$2,35
Total			INSUMOS - VALOR AL ORIGEN					\$2 547,32

LABORATORIO								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			LABORATORIO					\$0,00

IMAGEN(*)								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total

IMAGEN(*)											
					Total	IMAGEN(*)				\$0,00	
SERVICIOS INSTITUCIONALES											
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total			
2025-10-21	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90			
2025-10-21	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80			
2025-10-21	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90			
2025-10-21	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80			
					Total	SERVICIOS INSTITUCIONALES				\$147,40	
EQUIPOS ESPECIALES											
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total			
					Total	EQUIPOS ESPECIALES				\$0,00	
										TOTAL LIQUIDACION	\$3 118,28



.....

DRA. AURA EDITH ZAMBRANO PAREDES
C.I. 0926862152
JEFE DE CONVENIOS PÚBLICOS
DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA
PRESTADOR EXTERNO

SERVICIO GASTROENTEROLOGIA	Fecha de Elaboración:	2025-10-21
	Área-Proceso:	AUDITORIA MEDICA
INFORME TÉCNICO-MÉDICO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS		Página: 1

DATOS GENERALES	
NOMBRES Y APELLIDOS DE PACIENTE:	BLANCA EDITH ARTEAGA ZAMBRANO
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1301810196
CÓDIGO DE VALIDACIÓN QUE AUTORIZÓ PRESTACIÓN:	09CV-JCCHM-2025-001193
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE:	2025-10-21
MÉDICO SOLICITANTE:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD:	GASTROENTEROLOGO

DIAGNÓSTICOS (CIE-10):	
DIAGNÓSTICO(S) QUE JUSTIFICARON EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN:	K802 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS
DIGANÓSTICOS ACTUALES QUE JUSTIFICARÁN LA PRESTACIÓN ADICIONAL:	K802 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS

CUADRO CLÍNICO DEL PACIENTE QUE JUSTIFICARÁ PRESTACIÓN ADICIONAL	
PACIENTE FEMENINO DE 72 AÑOS DE EDAD, SE LE REALIZO CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA + ABLACION CON SONDA DE RADIOFRECUENCIA DE NEOPLASIA DE COLEDOCO DISTAL + COLOCACION DE STENT PLASTICOS PARA DRENAJE. NOTA: REQUIERE NUEVA CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA Y RADIOFRECUENCIA EN 12 SEMANASE ADEMÁS DE ECOENDOSCOPÍA + DRENAJE ECOENDOSCÓPICO COLECISTOGASTRICO (VESICULA-ANTRO) CON STENT AXIOS + COLOCACION DE STENT BILIAR DOBLE PIGTAIL DENTRO DEL AXIOS PARA EVITAR MIGRACION. ACUDE PARA RETIRO DE STENT VALORACION PARA RADIOFRECUENCIA. CARDIO SIN CONTRAINDICACION. APP: HTA, HIPOTRIOIDEA. COLELITIASIS. APQX: NEFRECTOMIA IZQ, MENISCO. ALERGIAS: NO REFIERE Diagnostico: K802 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS Conclusion: -EDA + PROTESIS METALICA MIGRADA A NIVEL DE FISTULA COLECISTO-ANTRAL + RETIRO DE PROTESIS METALICA Y STENT PLASTICO + COLOCACION DE PROTESIS BILIAR PLASTICA DOBLE PIGTAIL DE VESICULA A ANTRO PARA MANTENER DRENAJE VESICULAR.	

PROTOCOLOS UTILIZADOS QUE JUSTIFICAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL REALIZADA:					
NO.	PROTOCOLOS	TIPO * (SELECCIONE CON UNA X)			OBSERVACIONES
		NAC	INTERN.	MBE	
1	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Coordinación para la Formulación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención PROTOCOLO DE ATENCION PARA ACALASIA		X	X	1. Goldman, Pocket Guide to the Operating Room Philadelphia: F.A. Davis Company. M.A. (3rd e.). (2008). 2. Katz PO, Gerson LB, Vela MF.Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofagico. Am J Gastroenterol. 2013 Mar; 108 (3): 308- 28. [184 referencias] PubMed 3. Longstreth, Achalasia. G.F. MD (2012). http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000267.htm . 4. Stefanidis D, W Richardson, Farrell TM, Kohn GP, Augenstein V, Fanelli RD. SAGES directrices para el tratamiento quirúrgico de la acalasia esofágica. Los Ángeles (CA): Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (sabios); 2011 mayo.50 p. [128 referencias] 5. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. ACG guía clínica: diagnóstico y tratamiento de la acalasia. Am J Gastroenterol. 2.013 Aug; 108 (8): 1238 a 1249. [103 referencias]
2	Guías Clínicas AUGE Cáncer Gástrico Subsecretaría de Salud Pública División de prevención y Control de Enfermedades Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores		X		1. D. Max Parkin, Freddie Bray, J. Ferlay and Paola Pisani, Global Cancer Statistics, 2002 CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108 2. Ayala J.C., Lotero J.D. Tamización de cáncer gástrico Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 54 (2): 209-222, abril-junio, 2013 3. Calvo B., Alfonso Rev.Med.Clin.Condes-2011;22 (4)477-484). 4. Departamento de Estadística e Información en Salud, 2011 5. Csendes A, Smok G, Medina E, Salgado I, Rivera R, Quital M.[Clinical course characteristics of gastric cancer 1958-1990. Rev Med Chil. 1992 Jan; 120(1):36-42. 6. Allum WH, Griffin SM, Watson A, Colin-Jones D; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; British Society of Gastroenterology; British Association of Surgical Oncology. Guidelines for the management of oesophageal and gastric cancer. Gut. 2002 Jun; 50 Suppl 5:v1-23.]
3	Endoscopia gastrointestinal alta para diagnostico; incluye esófago; estómago y duodeno y/o yeyuno según el caso; para remoción de cuerpo extraño.		X		Endoscopia gastrointestinal alta para diagnostico; incluye esófago; estómago y duodeno y/o yeyuno según el caso; para remoción de cuerpo extraño.
4	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Coordinación para la Formulación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención PROTOCOLO DE ATENCION PARA ACALASIA		X	X	1. Goldman, Pocket Guide to the Operating Room Philadelphia: F.A. Davis Company. M.A. (3rd e.). (2008). 2. Katz PO, Gerson LB, Vela MF.Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofagico. Am J Gastroenterol. 2013 Mar; 108 (3): 308- 28. [184 referencias] PubMed 3. Longstreth, Achalasia. G.F. MD (2012). http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000267.htm . 4. Stefanidis D, W Richardson, Farrell TM, Kohn GP, Augenstein V, Fanelli RD. SAGES directrices para el tratamiento quirúrgico de la acalasia esofágica. Los Ángeles (CA): Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (sabios); 2011 mayo.50 p. [128 referencias] 5. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. ACG guía clínica: diagnóstico y tratamiento de la acalasia. Am J Gastroenterol. 2.013 Aug; 108 (8): 1238 a 1249. [103 referencias]

5	Guías Clínicas AUGE Cáncer Gástrico Subsecretaría de Salud Pública División de prevención y Control de Enfermedades Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores		X		1. D. Max Parkin, Freddie Bray, J. Ferlay and Paola Pisani, Global Cancer Statistics, 2002 CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108 2. Ayala J.C., Lotero J.D. Tamización de cáncer gástrico Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 54 (2): 209-222, abril-junio, 2013 3. Calvo B., Alfonso Rev.Med.Clin.Condes-2011;22 (4)477- 484). 4. Departamento de Estadística e Información en Salud, 2011 5. Csendes A, Smok G, Medina E, Salgado I, Rivera R, Quitral M.[Clinical course characteristics of gastric cancer 1958- 1990. Rev Med Chil. 1992 Jan; 120(1):36-42. 6. Allum WH, Griffin SM, Watson A, Colin-Jones D; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; British Society of Gastroenterology; British Association of Surgical Oncology. Guidelines for the management of oesophageal and gastric cancer. Gut. 2002 Jun; 50 Suppl 5:v1-23.]
*TIPO: NACIONALES (NAC), INTERNACIONALES (INTERN), BUENAS PRACTICAS MÉDICAS BASADAS EN MEDICNA BASADA EN EVIDENCIA (MBE)					

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES AL AUTORIZADO QUE SERÁN JUSTIFICADOS CON ESTE INFORME:			
NO.	COD. TARIFARIO	DESCRIPCIÓN	
1	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	
2	43247	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, PARA REMOCION DE CUERPO EXTRAÑO.	
Nota: Este informe no justifica la prescripción de medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sin la autorización debida según la normativa legal vigente para el caso, Homologaciones de procedimientos y/o laboratorios no autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, facturación indebida de acuerdo al Tarifario de Prestaciones de Salud pertinente y otras situaciones de igual similitud.			
	NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	FIRMA Y SELLO
Elaborado por:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO	 Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **130181019-6**

APellidos y Nombres
ARTEAGA ZAMBRANO
BLANCA EDITH

Lugar de Nacimiento
MANABI
CHONE
CHONE

Fecha de Nacimiento 1953-01-15
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo MUJER
Estado Civil CASADO
Julio Maximo
ZAMBRANO BASURTO







INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR EN GENERAL

E13311122

APellidos y Nombres del Padre
ARTEAGA ALAVA SEBASTIAN

APellidos y Nombres de la Madre
ZAMBRANO PAZMIÑO OLGA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL

2020-10-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-10-08

001723323

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO









Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 21 de Octubre del 2025

Nombre: BLANCA EDITH ARTEAGA ZAMBRANO

CI. 1301810196

Edad: 73 años

Alergia: NO

Rp:

Dr. Alcivar Vásquez Juan Manuel

GASTROENTEROLOGO

C.I. 1306579234



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 21 de Octubre del 2025

Nombre: BLANCA EDITH ARTEAGA ZAMBRANO

CI. 1301810196

Edad: 73 años

Alergia: NO

Prescripción:

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO			
IESS	42645	GASTROCLINICA	1301810196							
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
							H	D	M	A
ARTEAGA		ZAMBRANO	BLANCA	EDITH	Femenino	73				x

B. DIAGNÓSTICOS

Post Operatorio:	1	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	CIE
			K802

C. PROCEDIMIENTO

	Electiva	X	Emergencia		Urgencia	
Proyectado:	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS					
Realizado:	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS					

D. INTEGRANTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Cirujano 1:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	Instrumentista:	
Cirujano 2:		Circulante:	
Primer Ayudante:	Dr(a). ANCHUNDIA DELGADO FRANKLIN JAVIER	Anestesiologo/a:	Dr(a). ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA
Segundo Ayudante:		Ayudante Anestesia:	
Tercer Ayudante:		Otros:	

E. TIPO ANESTESIA

General	X	Regional		Sedación		Otros	
---------	---	----------	--	----------	--	-------	--

F. TIEMPOS QUIRÚRGICOS

FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION
	21	10	2025	11:00:00	12:00:00

Dieresis:	
-----------	--

--	--

Exposición y Exploración:	
---------------------------	--

--	--

Hallazgos Quirúrgicos:	
------------------------	--

-EDA + PROTESIS METALICA MIGRADA A NIVEL DE FISTULA COLECISTO-ANTRAL + RETIRO DE PROTESIS METALICA Y STENT PLASTICO + COLOCACION DE PROTESIS BILIAR PLASTICA DOBLE PIGTAIL DE VESICULA A ANTRO PARA MANTENER DRENAJE VESICULAR.

Procedimiento Quirúrgico:	
---------------------------	--

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE POR VIA ORAL. SE IDENTIFICA EN ANTRO LA PRESENCIA DE UN STENT DOBLE PIGTAIL, DE ANTRO A VESICULA, EL STENT METALICO AXIOS SE ENCUENTRA INCRUSTADO EN LA FISTULA, CON LA FORCEPS PINZA RATON (2.5MM/180CM) DESCARTABLE RETIRAMOS LA PROTESIS METALICA Y ADICIONALMENTE EL DOBLE PIGTAIL. A CONTINUACION CON EL Esfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable PROCEDEMOS A PASAR UNA GUÍA DE NITINOL HIDROFILICA PARA VÍAS BILIARES/PANCREATICA 0,035 X 450CM LONGITUD RECTA ESTÉRIL. DESCARTABLEA NIVEL DE LA LUZ VESICULAR ADEMAS DE LITOS DENTRO DE LA MISMA DE GRAN TAMAÑO, POR LO QUE FINALMENTE SE DECIDE CON EL CATETER RIEL RADIOPACO DESCARTABLE ACOPLADO AL EMPUJADOR 7 FR, LONG CATÉTER 2200 MM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLE COLOCAR UN STENT PLASTICO BILIAR DOBLE PIGTAIL 7FR X 5CM ESTERIL. DESCARTABLE PARA MANTENER DRENAJE VESICULO-ANTRAL Y EVITAR COLECISTITIS.

G. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

NO

Pérdida Sanguínea total:

ml

Muestra:

Descripción:

H. EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS

Transquirúrgico:

Biopsia por congelación:

SI

NO

Resultado:

Patólogo que reporta:

Histopatológico:

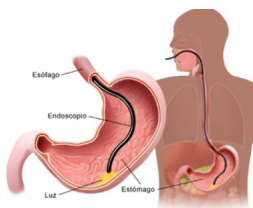
SI

x

NO

Muestra :

I. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO



J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	FIRMA	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140



A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO				
IESS				GASTROCLINICA				1301810196								
PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)				
												H	D	M	A	
ARTEAGA				ZAMBRANO		BLANCA		EDITH		Femenino	73				x	
FECHA	2025-10-21			TALLA	0	PESO KG	0	IMC		GRUPO Y FACTOR		CONSENTIMIENTO INFORMADO		SI		NO

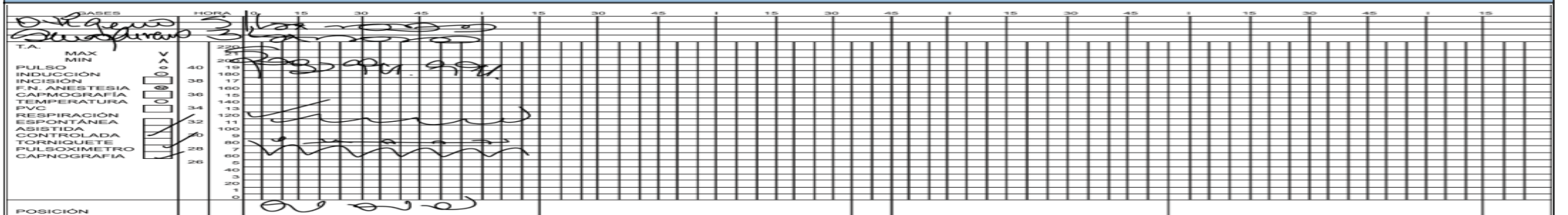
B. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO		CIE		CIRUGÍA PROPUESTA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+RETIRO DE STENT	ESPECIALIDAD	PRIORIDAD	EMERGENTE
DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO		CIE	K802	CIRUGÍA REALIZADA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+RETIRO DE STENT	GASTROENTEROLOGO		URGENTE
ANESTESIÓLOGO	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO	AYUDANTE (S)	VERENA ELIZABETH TANDAZO VALAREZO	INSTRUMENTISTA	MILENA ASTRID RIERA HOLGUIN	QUIRÓFANO		ELECTIVO
CIRUJANO	CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	AYUDANTE (S)	FRANKLIN JAVIER ANCHUNDIA DELGADO	CIRCULANTE				X
OTROS								

C. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

CABEZA		ÓRGANOS		CUELLO		COLUMNA		TÓRAX		ABDÓMEN	X	PELVIS		EXT.SUPERIORES		EXT.INFERIORES		PERINEAL	
--------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	---------	---	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------	--

D. REGISTRO TRANSANESTÉSICO



E. DROGAS ADMINISTRADAS

1	PROPOFOL 200MG/20ML (600MG)	2	BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML (10MG)	3	LIDOCAINA S/E 2% (20MG)	4	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (20MG)
5	ONDANSETRON 8MG/4ML (8MG)	6	FENTANILO 0.05MG/10ML (150MCG)	7	DEXAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (8MG)	8	CEFTRIAXONA: 1G
9	ATROPINA 1MG/ML - NEOSTIGMINA 0.5MG/ML (2MG)	10	KETOROLACO 30MG/ML (60MG)	11	OMEPRAZOL 40MG	12	
13		14		15		16	

F. TÉCNICA ANESTÉSICA

GENERAL												REGIONAL												SEDO - ANALGESIA											
SISTEMA						APARATO						ASEPSIA CON						HABÓN CON																	
ABIERTO		CERRADO		X	SEMICERRADO		CIRCUITO CIRCULAR			UNIDIRECCIONAL		LOCAL ASISTIDA						INTRAVENOSA																	
MANEJO DE VÍA AÉREA												TRONCULAR																							
MASCARA FACIAL					SUPRAGLOTICA					TRAQUEOTOMO				BLOQUEO DE NERVI				NÚMERO DE INTENTOS																	
INTUBACIÓN												BLOQUEO DE PLEXO				NÚMERO DE INTENTOS																			
NASAL	X		ORAL	X	SUBMENTONEANA					VISION DIRECTA					A CIEGAS				ANESTÉSICO LOCAL				COADYUVANTE												
TIPO DE TUBO												TIPO DE AGUJA				EQUIPO																			
CONVENCIONAL		X	PREFORMADO ORAL			PREFORMADO NASAL					REFORZADO				NEUROAXIAL																				
DOBLES LUMEN			DIÁMETRO		7	BALÓN	SI		X	NO		TAPONAMIENTO		SI		NO	RAQUIDEA			EPIDURAL					CAUDAL			CATETER							
EQUIPO DE INTUBACION												TIPO DE AGUJA				NUMERO DE AGUJA				N° DE INTENTOS															
CORMACK			I	X	II	X	III		IV		NUMERO INTENTOS		I	BORBOTAJE	SI		NO		ACCESO		MEDIAL		LATERAL	SITIO DE PUNCIÓN											
INDUCCION						MANTENIMIENTO																													
INHALATORIA		X	INTRAVENOSA		X	INHALATORIA			INTRAVENOSA		BALANCEADA		X	DERMATOMA		POSICIÓN																			

G. ACCESOS VASCULARES

TIPO	CALIBRE	SITIO	DEXTROSA 5%		SANGRE		SANGRADO
IV PERIFÉRICO 1	20	Miembro superior izquierdo	DEXTROSA 10%		PLASMA		DIURESIS
IV PERIFÉRICO 2			DEXTROSA 50%		PLAQUETAS		OTROS
IV PERIFÉRICO 3			DEXTROSA EN SS		CRIOPRECIPITADOS		
IV CENTRAL			SS 0.9%				TOTAL
INTRA ARTERIAL			LACTO RINGER	1000	OTROS		
OTRO			EXPANSORES		TOTAL	750	BALANCE

J. DATOS DEL RECIENTE NACIDO

APGAR	FETO MUERTO	1 MINUTO	5 MINUTOS	10 MINUTOS	DURACION ANESTESIA	01:00:00	DURACION CIRUGIA	01:00:00
-------	-------------	----------	-----------	------------	--------------------	----------	------------------	----------

K. TIEMPOS TRANSCURRIDOS

DURACION ANESTESIA	01:00:00	DURACION CIRUGIA	01:00:00
--------------------	----------	------------------	----------

L. TECNICAS ESPECIALES															
HEMODILUCIÓN			AUTOTRANSFUSIÓN			HIPOTENSIÓN			HIPOTERMIA			CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA			
M. MANTENIMIENTO TEMPERATURA CORPORAL															
MANTA TERMICA			CALENTAMIENTO DE FLUIDOS			OTROS									
N. INCIDENTES															
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO			ARRITMIA			ASISTOLIA			TRMBOEMBOLIA						
HIPERTERMIA MALIGNA			ANAFILAXIA			ISQUEMIA MIOCÁRDICA			NEUMOTÓRAX						
BRONCOESPASMO			DESPERTAR PROLONGADO			EMBOLIA AÉREA VENOSA			LARINGOESPASMO						
DIFICULTAD DE LA TÉCNICA			OTROS												
O. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO															
HORA	pH	PO2	PCO2	HCO3	EB	SAT. O2	LACTATO	GLUCOSA	Na	K	Cl	HCTO	HB	OTRO	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
P. OBSERVACIONES															
PACIENTE PASA A SALA DE RECUPERACIÓN EN CONDICIONES ESTABLES															
Q. CONDICIONES DE EGRESO															
CONDICIONES AL SALIR		EXTUBADO		CONDUCTIDO A	UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICO	X	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		CRÍTICOS DE EMERGENCIA		MORGUE				
		INTUBADO													
CONSTANTES VITALES DE ENTREGA		TA	108/70mmhg	FC	75	FR	14	SAT.O2		99	T°				
R. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE															
HORA	12:00:00	NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL	ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA			FIRMA	<i>Angelica H. Arrieta B.</i>		SELLO Y CÓDIGO	Dra. ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA ANESTESIOLOGIA Cedula No. 1759345422					

Paciente:	ARTEAGA ZAMBRANO BLANCA EDITH	Edad:	73 años	Identificacion:	1301810196
Procedimiento:	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA				
Referido por:		Fecha:	21/10/2025		



Hallazgos

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICO POR VIA ORAL. SE IDENTIFICA EN ANTRO LA PRESENCIA DE UN STENT DOBLE PIGTAIL, DE ANTRO A VESICULA, EL STENT METALICO AXIOS SE ENCUENTRA INCRUSTADO EN LA FISTULA, CON LA PINZA DE RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO DESCARTABLE RETIRAMOS LA PROTESIS METALICA Y ADICIONALMENTE EL DOBLE PIGTAIL, FINALMENTE, CON EL ESFINTEROTOMO PROCEDEMOS A PASAR UN HILO GUIA A NIVEL DE LA LUZ VESICULAR ADEMAS DE LITOS DENTRO DE LA MISMA DE GRAN TAMAÑO, POR LO QUE FINALMENTE SE DECIDE CON EL CATETER RIEL RADIOPACO DESCARTABLE ACOPLADO AL CATETER EMPUJADOR COLOCAR UN STENT PLASTICO BILIAR DOBLE PIGTAIL DE 7FRX4CM PARA MANTENER DRENAJE VESICULO-ANTRAL Y EVITAR COLECISTITIS.

Conclusiones

EDA + PROTESIS METALICA MIGRADA A NIVEL DE FISTULA COLECISTO-ANTRAL + RETIRO DE PROTESIS METALICA Y STENT PLASTICO + COLOCACION DE PROTESIS BILIAR PLASTICA DOBLE PIGTAIL DE VESICULA A ANTRO PARA MANTENER DRENAJE VESICULAR.



Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO USUARIO / PACIENTE

INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NUMERO DE HISTORIA CLINICA	NUMERO DE ARCHIVO		No.HOJA			
IESS	42645	GASTROCLINICA		1301810196						
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)				
						H	D	M	A	
ARTEAGA	ZAMBRANO	BLANCA	EDITH	Femenino	73				x	

B. EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES
FIRMAR AL PIE DE CADA EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN
REGISTRAR CON ROJO LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. EVOLUCIÓN			2. PRESCRIPCIONES	
FECHA (aaaa- mm - dd)	HORA (hh:mm)	NOTAS DE EVOLUCIÓN	FARMACOTERAPIA E INDICACIONES(Para enfermería y otro profesional de salud)	ADMINISTR. FARMACOS DISPOSITIVOS
21/10/2025	09:00	PACIENTE FEMENINO DE 72 AÑOS DE EDAD, SE LE REALIZO CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA + ABLACION CON SONDA DE RADIOFRECUENCIA DE NEOPLASIA DE COLEDOCO DISTAL + COLOCACION DE STENT PLASTICOS PARA DRENAJE. NOTA: REQUIERE NUEVA CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA Y RADIOFRECUENCIA EN 12 SEMANASE ADEMAS DE ECOENDOSCOPÍA + DRENAJE ECOENDOSCOPICO COLECISTOGASTRICO (VESICULA-ANTRO) CON STENT AXIOS + COLOCACION DE STENT BILIAR DOBLE PIGTAIL DENTRO DEL AXIOS PARA EVITAR MIGRACION.ACUDE PARA RETIRO DE STENT VALORACION PARA RADIOFRECUENCIA. CARDIO SIN CONTRAINDICACION. APP: HTA, HIPOTRIOIDEA. COLELITIASIS. APQX: NEFRECTOMIA IZQ, MENISCO. ALERGIAS: NO REFIERE	1.- CSV 2.- PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO 3.- SOL SAL 0,9% 1000cc a 30gts x min 4.-SEGUIR INDICACIONES DE MEDICO RESIDENTE 5.-SE SOLICITA EXAMENES PRE-QUIRURGICOS	
21/10/2025	12:00	PASE A SALA DE RECUPERACION DESPUES DE PROCEDIMIENTO CON SIGNOS VITALES ESTABLES.	1.- BUTIL BROMURO DE HIOSCINBA IV PRN 2.- SEGUIR INDICACIONES	
21/10/2025	13:00	PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.		



Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
GASTROENTEROLOGO
cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICÓDIGO		ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA		NÚMERO DE ARCHIVO		No. HOJA
IESS	42645		GASTROCLINICA		1301810196				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						D	H	M	A
ARTEAGA	ZAMBRANO	BLANCA	EDITH	FEMENINO	73				X

B. RESUMEN DE CUADRO CLINICO

PACIENTE FEMENINO DE 72 AÑOS DE EDAD, SE LE REALIZO CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA + ABLACION CON SONDA DE RADIOFRECUENCIA DE NEOPLASIA DE COLEDOCO DISTAL + COLOCACION DE STENT PLASTICOS PARA DRENAJE. NOTA: REQUIERE NUEVA CPRE + RETIRO DE STENT + COLEDOSCOPÍA Y RADIOFRECUENCIA EN 12 SEMANASE ADEMAS DE ECOENDOSCOPIA + DRENAJE ECOENDOSCOPICO COLECISTOGASTRICO (VESICULA-ANTRO) CON STENT AXIOS + COLOCACION DE STENT BILIAR DOBLE PIGTAIL DENTRO DEL AXIOS PARA EVITAR MIGRACION. ACUDE PARA RETIRO DE STENT VALORACION PARA RADIOFRECUENCIA. CARDIO SIN CONTRAINDICACION.
APP: HTA, HIPOTRIOIDEA. COLELITIASIS.
APQX: NEFRECTOMIA IZQ, MENISCO.
ALERGIAS: NO REFIERE
PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS.

PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.

C. RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES

Evolución	Complicación
FAVORABLE	NINGUNA

D. HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

-EDA + PROTESIS METALICA MIGRADA A NIVEL DE FISTULA COLECISTO-ANTRAL + RETIRO DE PROTESIS METALICA Y STENT PLASTICO + COLOCACION DE PROTESIS BILIAR PLASTICA DOBLE PIGTAIL DE VESICULA A ANTRO PARA MANTENER DRENAJE VESICULAR.

DATOS DEL USUARIO / PACIENTE				
PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	EDAD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO
ARTEAGA	BLANCA	73	1301810196	

E. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOENDOSCOPIO TERAPEUTICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLEPOR VIA ORAL. SE IDENTIFICA EN ANTRO LA PRESENCIA DE UN STENT DOBLE PIGTAIL, DE ANTRO A VESICULA, EL STENT METALICO AXIOS SE ENCUENTRA INCRUSTADO EN LA FISTULA, CON LA FORCEPS PINZA RATON (2.5MM/180CM) DESCARTABLE RETIRAMOS LA PROTESIS METALICA Y ADICIONALMENTE EL DOBLE PIGTAIL. A CONTINUACION CON EL Esfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable PROCEDEMOS A PASAR UNA GUÍA DE NITINOL HIDROFILICA PARA VÍAS BILIARES/PANCREATICA 0,035 X 450CM LONGITUD RECTA ESTÉRIL. DESCARTABLE A NIVEL DE LA LUZ VESICULAR ADEMAS DE LITOS DENTRO DE LA MISMA DE GRAN TAMAÑO, POR LO QUE FINALMENTE SE DECIDE CON EL CATETER RIEL RADIOPACO DESCARTABLE ACOPLADO AL EMPUJADOR 7 FR, LONG CATÉTER 2200 MM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLE COLOCAR UN STENT PLASTICO BILIAR DOBLE PIGTAIL 7FR X 5CM ESTERIL. DESCARTABLE PARA MANTENER DRENAJE VESICULO-ANTRAL Y EVITAR COLECISTITIS.

F. INDICACIONES DE ALTA / EGRESO
PRÓXIMO CONTROL

G. DIAGNOSTICO DE ALTA / EGRESO			CIE
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS		K802
CAUSA EXTERNA			

H. CONDICIÓN DE ALTA / EGRESO					VIVO		FALLECIDO	
ALTA MÉDICA	X	DISCAPACIDAD		RETIRO NO AUTORIZADO		DEFUNCIÓN MENOS DE 48 HORAS		DÍAS DE ESTADIA
ALTA VOLUNTARIA				AUTORIZADO		DEFUNCIÓN MAS DE 48 HORAS		DÍAS DE REPOSO

I. MÉDICOS TRATANTES			
NOMBRE Y APELLIDOS		ESPECIALIDAD	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL
1.	Dr. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	GASTROENTEROLOGO	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140

J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
FECHA	HORA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-21		Dr. CARLOS	ROBLES	MEDRANDA
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		FIRMA		SELLO
1307189140				Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140
ELABORADO POR:		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO		REVISADO POR: Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO